

131~135 ★★★	68 歳男性、PS1。咳嗽の精査で肺扁平上皮癌 clinical T3N2M0 stage ⅢB と診断され、シスプラチン+ドセタキセル 2 コースと同時放射線療法を受けた。治療終了時の CT 検査では腫瘍の縮小と grade 1 の放射線肺臓炎がみられた。ドライバー遺伝子変異なし、PD-L1 50%。その後の地固め療法として正しいものを 1 つ選べ。
131 ☒ ☒ ☒	デュルバルマブ
132 ☒ ☒ ☒	ドセタキセルの地固め療法 2 コース後にデュルバルマブ
133 ☒ ☒ ☒	シスプラチン+ドセタキセルを計 4 コースまで投与後にデュルバルマブ
134 ☒ ☒ ☒	ペムブロリズマブ 単剤
135 ☒ ☒ ☒	grade 1 の放射線肺臓炎が出現したため、地固め療法は実施しない。
136~139 ★★★	72 歳女性、PS1。肺腺癌 stage IV EGFR ex21 L858R 陽性に対してアファチニブを投与されていたが、3 ヶ月前に肺内転移の増大があり、RECIST 評価で PD となった。1 ヶ月前に同部位に対して TBLB による再生検を受けたところ、L858R+、T790M- であった。血漿を用いたリキッドバイオプシーでは L858R+、T790M+ であった。次のうち正しいものを 2 つ選べ。
136 ☒ ☒ ☒	組織検体による検査結果よりもリキッドバイオプシーの検査結果の方が信頼性が低いため、T790M 陽性とは判断できない。
137 ☒ ☒ ☒	肺病変の再生検では癌細胞は採取できていなかった。
138 ☒ ☒ ☒	オシメルチニブの治療を検討する。
139 ☒ ☒ ☒	リキッドバイオプシーが陽性であり、循環腫瘍細胞の DNA が検出されたと考えられる。

